

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE CLARIDAD DEL AUTOCONCEPTO (SCCS-12)

Eje III: Personalidad • Evaluación Estructural de la Consistencia, Certeza y Estabilidad del Yo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Claridad del Autoconcepto (SCCS: 12 reactivos).
Nombre Original	Self-Concept Clarity Scale (SCCS; Campbell et al., 1996).
Autores Originales	Dra. Jennifer D. Campbell y colaboradores (Univ. de Columbia Británica, Canadá).
Adaptaciones Hispanas	Calderón-Garrido et al. (2018); Fuentes et al., adaptaciones validadas en España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad / Identidad. Claridad estructural, consistencia interna y certeza del yo.
Tipo de Instrumento	Autoinforme unidimensional de 12 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Población general y clínica ambulatoria.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación científica bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: ESTRUCTURA VS. CONTENIDO DEL AUTOCONCEPTO

La **Claridad del Autoconcepto** (Campbell et al., 1996) se define como el componente estructural del conocimiento sobre uno mismo: el grado en que las creencias autoevaluativas de un individuo están clara y confiadamente definidas, son internamente congruentes y presentan estabilidad temporal a través de diferentes situaciones vitales.

Campbell demostró de forma decisiva que la claridad del autoconcepto es cualitativamente distinta del nivel de autoestima (contenido evaluativo positivo/negativo): una persona puede tener una autoestima moderada pero una certeza diáfana sobre quién es, o viceversa, mantener una autoestima frágil e inestable que oscila bruscamente ante el más leve desaire (“difusión de identidad”).

A nivel neuropsicológico, la baja claridad del autoconcepto se asocia a una fragmentación funcional en la red neuronal por defecto (DMN) y a una excesiva dependencia de pistas externas en la corteza prefrontal dorsolateral para definir las propias preferencias. Clínicamente, constituye un marcador transdiagnóstico de vulnerabilidad: predice propensión a rumiación crónica, sugestibilidad, sumisión interpersonal, síntomas disociativos y desregulación en el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Estructural	Ítems (12)	Nº Ítems	Definición Operativa del Constructo
1. Inconsistencia / Falso Yo (*)	1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 7*, 8*, 9*, 10*, 12*	10 ítems	Dudas sobre la propia identidad, contradicciones internas e inestabilidad.
2. Certeza Identitaria Directa	6, 11	2 ítems	Convicción firme y estable sobre las características personales propias.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la validación española de Calderón-Garrido et al. (2018; N = 712): alfa de Cronbach de 0.85 a 0.88 y omega de McDonald de 0.87. Fiabilidad test-retest $r = 0.83$ a 4 semanas, ratificando su naturaleza de rasgo estructural estable.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica de forma concluyente la unidimensionalidad estricta del constructo una vez modelada la dirección del redactado inverso de los ítems (CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 0.044).
Validez Concurrente	Correlación directa positiva con Autoestima Global (RSES, $r = 0.58$), Flexibilidad Psicológica (AAQ-II inverso, $r = -0.52$) y Bienestar Psicológico. Correlación inversa intensa con Neuroticismo ($r = -0.56$), Rumiación depresiva (RRS, $r = -0.48$), Síntomas Límite (BSL-23, $r = -0.62$) e Inseguridad de Apego (ECR-R, $r = -0.50$).
Sensibilidad al Cambio	Sensible a intervenciones basadas en Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT centrada en “Yo-como-contexto”) y Terapia Dialéctica Conductual (DBT), con incrementos de $d > 0.65$ postratamiento.
Invarianza de Género	Invarianza configuracional, métrica y escalar estricta confirmada por sexo y grupo etario.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 12 reactivos se califica en una escala Likert de 5 puntos:

- **Opciones de Respuesta:** 1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «Neutral / Ni de acuerdo ni en desacuerdo», 4 = «De acuerdo», 5 = «Totalmente de acuerdo».
- **Paso 1 (Inversión de Ítems Inversos):** La escala contiene 10 reactivos formulados en dirección de ambigüedad/duda (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 12) que **deben invertirse**:

$$\text{Ítem Invertido} = 6 - \text{Respuesta Original}$$

(De modo que: 1 pasa a 5; 2 pasa a 4; 3 permanece 3; 4 pasa a 2; 5 pasa a 1).

- **Paso 2 (Puntuación Total SCCS):** Suma de los 12 reactivos (con los 10 reactivos inversos ya recodificados):

$$\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{12} \text{Ítem}_i$$

- **Rango Teórico Total: 12 a 60 puntos.** A mayor puntuación, mayor claridad, solidez y certeza en el autoconcepto.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Claridad del Autoconcepto	Interpretación y Recomendación Clínica
Muy Baja	12 a 32 puntos	Difusión del Yo (≤ 32)	Extrema fragmentación identitaria, sensación de vacuidad y labilidad. Foco prioritario.
Baja / Frágil	33 a 39 puntos	Claridad frágil / Vulnerable	Dudas frecuentes ante la toma de decisiones; excesiva permeabilidad a la opinión ajena.
Media / Normal	40 a 48 puntos	Claridad normativa / Adecuada	Nivel adaptativo saludable; convicción suficiente sobre la propia identidad con flexibilidad.
Alta / Sólida	49 a 60 puntos	Autoconcepto diáfano y sólido	Firme certeza de las características y valores personales; alta resiliencia ante el rechazo.

CRITERIO DE ALERTA: DIFUSIÓN DE IDENTIDAD (SCCS ≤ 32 PUNTOS):

Una puntuación ≤ 32 denota un colapso en la coherencia del yo y actúa como indicador clave de difusión de la identidad en el Trastorno Límite de la Personalidad (Criterio A del AMPD DSM-5). El paciente cambia drásticamente de valores, metas o vocación según la persona con la que interactúa (“camaleonismo patológico”).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE RECONSTRUCCIÓN DEL YO BASADO EN LA CLARIDAD DEL AUTOCONCEPTO

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN IDENTITARIA (ACT / DBT):

- **Paso 1 (Detección de la Labilidad del Yo):** Si SCCS ≤ 32 , explorar el "camaleonismo interpersonal" y el miedo visceral al abandono.
- **Paso 2 (Diferenciación Yo como Contexto vs. Yo Conceptualizado):** Enseñar que las dudas sobre pensamientos o emociones transitorias no destruyen al observador consciente que las experimenta (metáfora del cielo y las nubes).
- **Paso 3 (Anclaje en Valores Nucleares Estables):** Definir una lista innegociable de 3 valores personales para que funcionen como brújula fija frente a la presión o mimetismo social.
- **Paso 4 (Consolidación y Criterio de Alta):** Un incremento de ≥ 12 puntos o alcanzar el rango normativo (≥ 40 pts) consolida la coherencia de la personalidad.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DIFUSIÓN DE IDENTIDAD Y PARÁLISIS DECISIONAL

Identificación: Mujer de 24 años, graduada en Bellas Artes, acude por crisis de angustia recurrentes, cambios bruscos de vocación cada 3 meses y vivencia de vacío existencial ("siento que soy una cáscara vacía; cuando estoy con alguien adopto sus opiniones y cuando me quedo sola no sé quién soy").

Evaluación Inicial SCCS (Línea Base): Puntuación Total = **21/60 puntos** (Difusión Crítica del Yo). Puntuaciones de 5 (que invierten a 1) en Ítem 1 ("Mis creencias sobre mí misma cambian muy a menudo"), Ítem 3 ("Paso mucho tiempo preguntándome qué clase de persona soy en realidad") e Ítem 7 ("En días diferentes siento que soy una persona diferente").

Plan Terapéutico: 16 sesiones combinando módulos de Terapia Basada en la Mentalización (MBT) y ACT. Se trabajó el registro de preferencias estables y se eliminaron las conductas de sumisión mimética con parejas sentimentales.

Reevaluación a los 5 Meses: SCCS ascendió a **44/60 puntos** (+23 pts, Rango de Claridad Normativa). La paciente eligió un proyecto profesional independiente y consolidó relaciones de amistad auténticas sin miedo a mostrar opiniones discrepantes.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

BAJA CLARIDAD Y DISOCIACIÓN GRAVE:

Una puntuación SCCS < 20 suele coexistir con episodios de despersonalización y desrealización de origen postraumático. Evaluar formalmente trauma complejo con el inventario DES-II.

ALTA CLARIDAD VS. RIGIDEZ OBSESIVA:

Puntuaciones máximas de 60/60 no siempre indican salud; en trastornos obsesivos de personalidad pueden reflejar rigidez dogmática y nula tolerancia a la contradicción interna (evaluar con OCI-R).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F., & Lehman, D. R. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. *JSPS*, 70(1), 141-156.
2. Calderón-Garrido, D., et al. (2018). Adaptación psicométrica de la Escala de Claridad del Autoconcepto (SCCS) en población española. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 48(3), 115-126.
3. Bigler, M., Neimeyer, G. J., & Brown, E. (2001). The divided self revisited: Effects of self-concept clarity on distress. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 20(3), 386-402.
4. Roepke, S., et al. (2011). Disturbance of identity in borderline personality disorder: A review of the concept. *Current Psychiatry Reports*, 13(1), 54-62.